

02

CHAPITRE

02

Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé

Déterminants de santé | Inégalités | Mesure de l'état de santé

DANS CE VOLUME

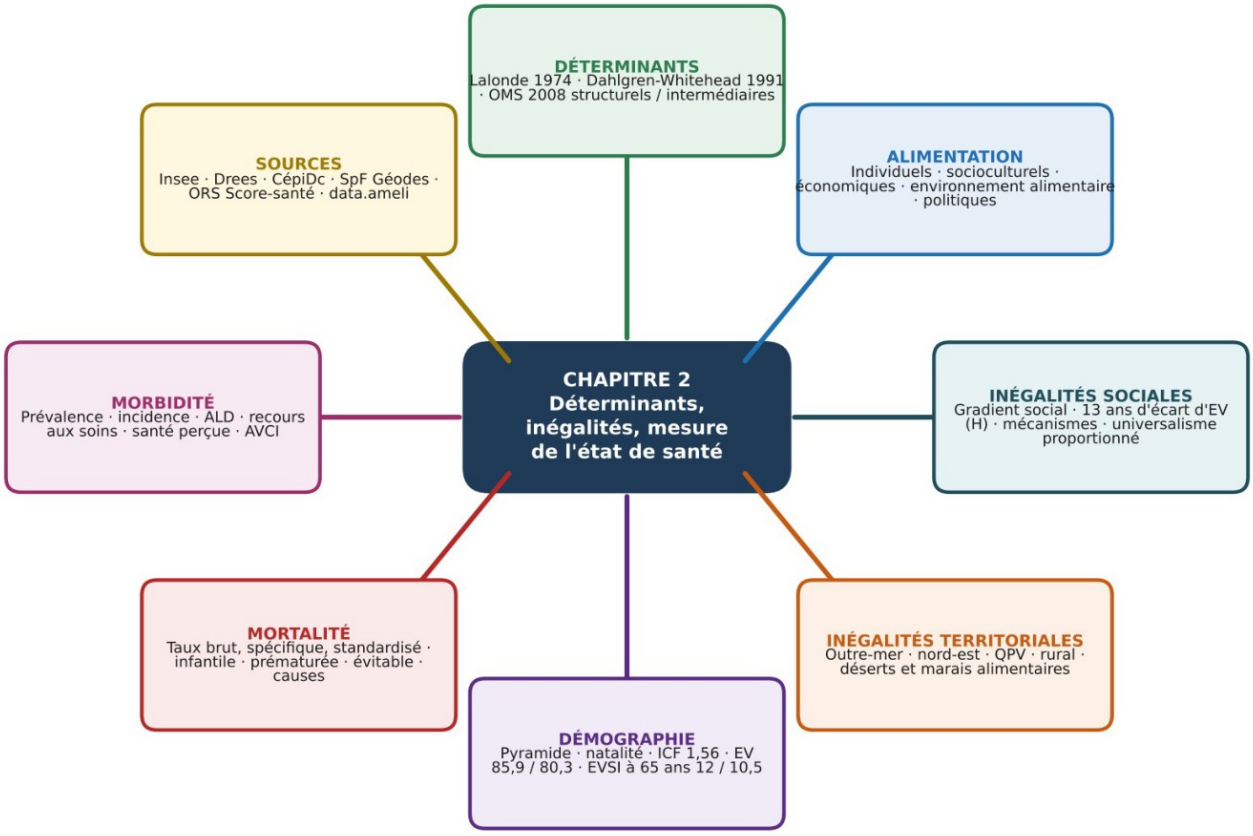
- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

Sommaire

Fiche de révision du chapitre 2 3
1. Les définitions à savoir 3
2. Les trois modèles de déterminants 4
3. Les formules 4
4. Chiffres-clés 4
5. Les pièges 4
6. Méthode express : portrait de territoire en 6 étapes 5
7. Auto-test 5
8. Flashcards 5
Compléments du chapitre enrichi 5
Fiches-outils du chapitre 2 6
O2.1 – Grille des déterminants de l'alimentation de mon public 6
O2.2 – Tableau d'indicateurs comparés 6
O2.3 – Calcul d'un taux standardisé (méthode directe) 6
O2.4 – Repérer les inégalités dans mon projet 7
O2.5 – Grille de lecture critique d'un indicateur 7

Fiche de révision du chapitre 2

Déterminants de santé, inégalités sociales et territoriales, mesure de l'état de santé



Carte mentale du chapitre 2

1. Les définitions à savoir

Notion	Définition	Source
Déterminant de santé	Facteur personnel, social, économique, environnemental ou politique qui influence l'état de santé	OMS, 1998
Inégalités sociales de santé	Différences de santé systématiques, socialement produites, évitables et injustes	OMS 2008
Gradient social	La santé s'améliore à chaque échelon de l'échelle sociale	Marmot
Environnement alimentaire	Conditions de disponibilité, accessibilité, attractivité et qualité des aliments	–
Précarité alimentaire	Difficulté d'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de qualité et suffisante	Art. L. 266-1 CASF
Espérance de vie	Durée de vie moyenne d'une génération fictive soumise aux taux de mortalité de l'année	Insee
EVSI	Années de vie sans limitation d'activité	Drees
Prévalence / incidence	Cas existants à un instant / nouveaux cas sur une période rapportés à la population à risque	–

2. Les trois modèles de déterminants

Modèle	Contenu
Lalonde (1974)	Biologie humaine – environnement – habitudes de vie – organisation des soins
Dahlgren et Whitehead (1991)	5 couches : individu ; style de vie ; réseaux ; conditions de vie et de travail ; conditions générales
OMS (2008, Solar et Irwin 2010)	Structurels (contexte, position sociale) → intermédiaires (matériels, psychosociaux, comportements, système de santé) → équité

3. Les formules

Indicateur	Formule
Taux brut de natalité / mortalité	Naissances (ou décès) / population moyenne × 1 000
Taux spécifique	Décès du groupe / population du groupe × 1 000
Taux standardisé direct	(taux spécifique × pop. de référence du groupe) / pop. de référence totale Σ
Mortalité infantile	Décès < 1 an / naissances vivantes × 1 000
Rapport de dépendance	(< 20 ans + ≥ 65 ans) / (20-64 ans) × 100
Indice de vieillissement	≥ 65 ans / < 20 ans × 100
Prévalence	Cas existants / population
Incidence cumulée	Nouveaux cas / population à risque au début
Écart en points / écart relatif	A − B / (A − B) / B × 100

4. Chiffres-clés

- 69,1 millions d'habitants (1er janvier 2026) ; 22,2 % de 65 ans ou plus ; ICF 1,56 ; solde naturel − 6 000 en 2025 (Insee).
- Espérance de vie 2025 : 85,9 ans (F), 80,3 ans (H) ; EVSI à 65 ans (2024) : 11,8 ans (F), 10,5 ans (H).
- 641 046 décès en 2024 : tumeurs 27,1 %, maladies cardio-neurovasculaires 21,2 %.
- ≈ 13 ans (H) et 8 ans (F) d'écart d'espérance de vie entre les 5 % les plus aisés et les plus modestes (Insee, 2018).
- Obésité 18,1 % ; 24,7 % en cas de difficultés économiques ; 22,4 % en outre-mer (OFÉO, 2024). Précarité alimentaire 16 % (Crédoc, 2022).

5. Les pièges

Attention

- Comparer deux territoires avec des **taux bruts** → utiliser des taux **standardisés**.
- Confondre **effectif**, **proportion** et **taux**.
- Oublier d'exclure les malades du dénominateur de l'**incidence**.
- Confondre écart **en points** et écart **relatif**.
- Croire que les inégalités ne concernent que les plus pauvres (oubli du **gradient**).
- Présenter une donnée sans **année** ni **source**.

6. Méthode express : portrait de territoire en 6 étapes

1. Délimiter le territoire et le public. 2. Démographie (Insee). 3. Situation sociale (Insee, QPV). 4. État de santé (ORS, Géodes, Assurance maladie, santé scolaire). 5. Déterminants et ressources (observation, entretiens). 6. Comparer, dater, sourcer, rédiger 3 à 5 constats.

7. Auto-test

1. Citez les 4 champs de Lalonde. 2. Donnez un déterminant structurel et un intermédiaire. 3. Qu'est-ce que le gradient social ? 4. Écart d'espérance de vie entre hommes aisés et modestes ? 5. Formule du taux de mortalité infantile ? 6. Pourquoi standardiser ? 7. ICF en 2025 ? 8. Première cause de décès ? 9. Une commune : 200 décès, 25 000 habitants : taux brut ? 10. Prévalence 45/320 ? 11. Définition d'un marais alimentaire ? 12. Quelle loi définit la lutte contre la précarité alimentaire ? *Réponses : 1. Biologie, environnement, habitudes de vie, organisation des soins – 2. Revenu / consommation de sodas – 3. Santé meilleure à chaque échelon social – 4. ≈ 13 ans – 5. Décès < 1 an / naissances vivantes × 1 000 – 6. Pour éliminer l'effet de la structure par âge – 7. 1,56 – 8. Tumeurs (27 %) – 9. 200 / 25 000 × 1 000 = 8,0 ‰ – 10. 14,1 % – 11. Zone saturée d'offre peu favorable (restauration rapide) – 12. Loi EGalim (art. L. 266-1 CASF).*

8. Flashcards

Recto : Déterminants structurels selon l'OMS ?	Verso : Contexte socio-économique et politique + position sociale (éducation, profession, revenu, genre, origine)
Recto : Taux standardisé direct : principe ?	Verso : Appliquer les taux par âge de chaque population à une même population de référence
Recto : EVSI à 65 ans (2024) ?	Verso : 11,8 ans (femmes) ; 10,5 ans (hommes)
Recto : Prévalence = ?	Verso : ≈ incidence × durée (situation stable)
Recto : Désert vs marais alimentaire ?	Verso : Manque d'accès aux aliments frais / excès d'offre peu favorable
Recto : Causes de décès 2024 ?	Verso : Tumeurs 27,1 % ; cardio-neurovasculaires 21,2 %

Compléments du chapitre enrichi

Notion	À retenir
Transitions	Démographique (4 phases) ; épidémiologique (Omran, 1971) ; nutritionnelle (Popkin) ; double fardeau
Vieillissement	Indice = 65+ / moins de 20 ans × 100 ; dépendance = (moins de 20 + 65+) / 20-64 × 100
Fardeau	Adultes : 49 % surpoids dont 17 % obésité (Esteban 2015) ; 41 % des cancers liés à des facteurs modifiables (CIRC 2018) ; AVCI = AVP + AVI
Association	RR = R1/R0 ; DR = R1 − R0 ; OR = ad/bc ; FA = (RR − 1)/RR ; association ≠ causalité ; confusion
Inégalités	Obésité GS : 5,8 % (ouvriers) / 1,3 % (cadres) ; insécurité alimentaire 11 % (INCA 3) ; 16 % (Crédoc 2022) ; écart absolu et relatif
Enquêtes	INCA 3, Esteban, Albane, Elfe, NutriNet-Santé, Constances, SNDS ; transversale / cohorte / essai
Coût	Journée conforme aux repères ≈ 3,5 € (exemple) ; comparer par portion ; lentilles 0,16 € la portion
Périnatalité	Mortalité infantile ≈ 4 ‰ ; prématurité, petits poids, allaitement, certificats du 8e jour, 9e et 24e mois

Fiches-outils du chapitre 2

Outil	Intitulé	Utilité
O2.1	Grille des déterminants de l'alimentation de mon public	Analyser les causes d'un problème (F1, F2)
O2.2	Tableau d'indicateurs comparés territoire / référence	Construire le portrait chiffré
O2.3	Calcul d'un taux standardisé (méthode directe)	Comparer deux territoires
O2.4	Repérer les inégalités sociales et territoriales dans mon projet	Appliquer l'universalisme proportionné
O2.5	Grille de lecture critique d'un indicateur	Vérifier un chiffre avant de le citer

O2.1 – Grille des déterminants de l'alimentation de mon public

Catégorie	Déterminants observés (avec source)	Levier possible
Individuels (âge, santé, goûts, compétences, temps)		
Sociaux et culturels (famille, normes, religion, culture)		
Économiques (revenus, prix, aides)		
Environnement alimentaire (commerces, restauration, marketing)		
Environnement physique (logement, équipement, transports)		
Politiques et systèmes (cantine, aide alimentaire, programmes)		

O2.2 – Tableau d'indicateurs comparés

Indicateur	Mon territoire	Département	Région / France	Écart (points ou rapport)	Source et année
Population					
Moins de 20 ans (%)					
65 ans ou plus (%)					
Taux de pauvreté (%)					
Familles monoparentales (%)					
Sans diplôme (%)					
Espérance de vie / ICM					
Mortalité prématurée (taux standardisé)					
ALD diabète (taux standardisé)					
Surpoids des enfants					

O2.3 – Calcul d'un taux standardisé (méthode directe)

Âge	Pop. A	Décès A	Taux A (‰)	Pop. B	Décès B	Taux B (‰)	Pop. de référence
Total							

Calcul	Territoire A	Territoire B
Taux brut = décès / population × 1 000		
Décès attendus = (taux spécifique × pop. de référence / 1 Σ 000)		
Taux standardisé = décès attendus / pop. de référence × 1 000		
Conclusion		

O2.4 – Repérer les inégalités dans mon projet

Question	Réponse
Quels groupes de mon public sont les plus défavorisés	
(revenu, quartier, langue, handicap, isolement) ?	
Quelles barrières risquent de les empêcher de participer	
(horaires, coût, transport, lecture, numérique) ?	
Quelle partie de l'action est universelle (pour tous) ?	
Quel renforcement pour les plus défavorisés	
(universalisme proportionné) ?	
Quel indicateur me permettra de vérifier que l'action	
profite aussi aux plus défavorisés ?	
Quelles précautions pour ne pas stigmatiser ?	

O2.5 – Grille de lecture critique d'un indicateur

Question	Réponse	OK ?
Quel est l'indicateur exact (numérateur, dénominateur, unité) ?		☐
Quelle population (âge, sexe, territoire) ?		☐
Quelle année de recueil ?		☐
Mesuré ou déclaré ? Quel échantillon ?		☐
Taux brut ou standardisé ?		☐
Quelle valeur de référence pour comparer ?		☐
Quelle source (organisme, document, lien) ?		☐